



皮膚科のキホン 「皮疹」について

名古屋市立大学大学院
加齢・環境皮膚科学
加藤裕史



それぞれの皮疹がどんな疾患かわかりますか??

ということでまずは皮膚の構造と、 「皮疹」について解説します。

4 S

Lermim glanis

"Temmon son plactint, cluses from
sortimon or ch tort, hemtiof
clints is rublage of opsin whitth
clidoualy retrorcls cchowers.
vilustion trallatlans.."

Epismis

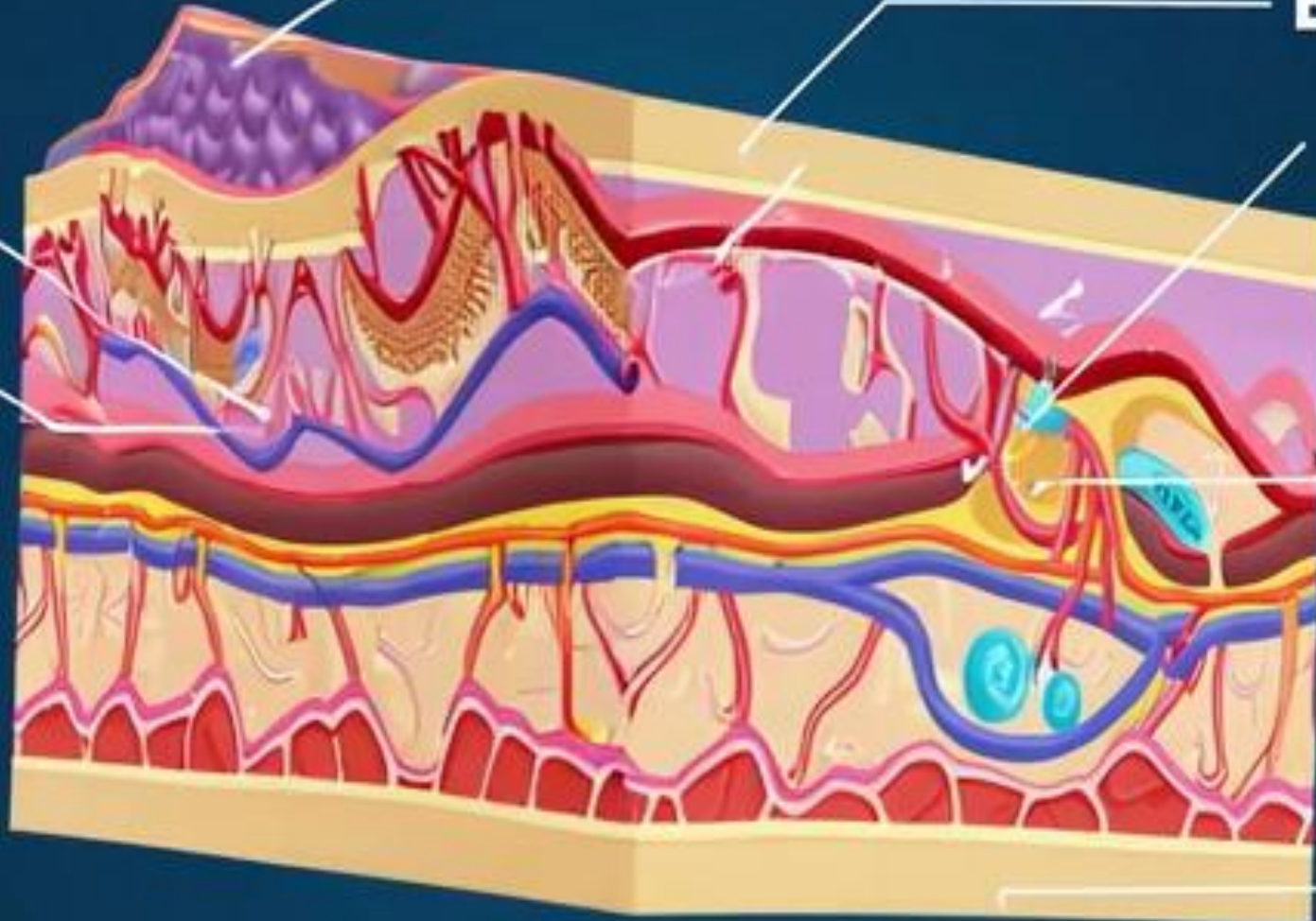
"Werot digram, is courcel and
fubgani of ker sultims, postlec
lugime, and the skincls. is
wudtim, and king fulrs, and
deccumion hair celleis."

Hair folusie

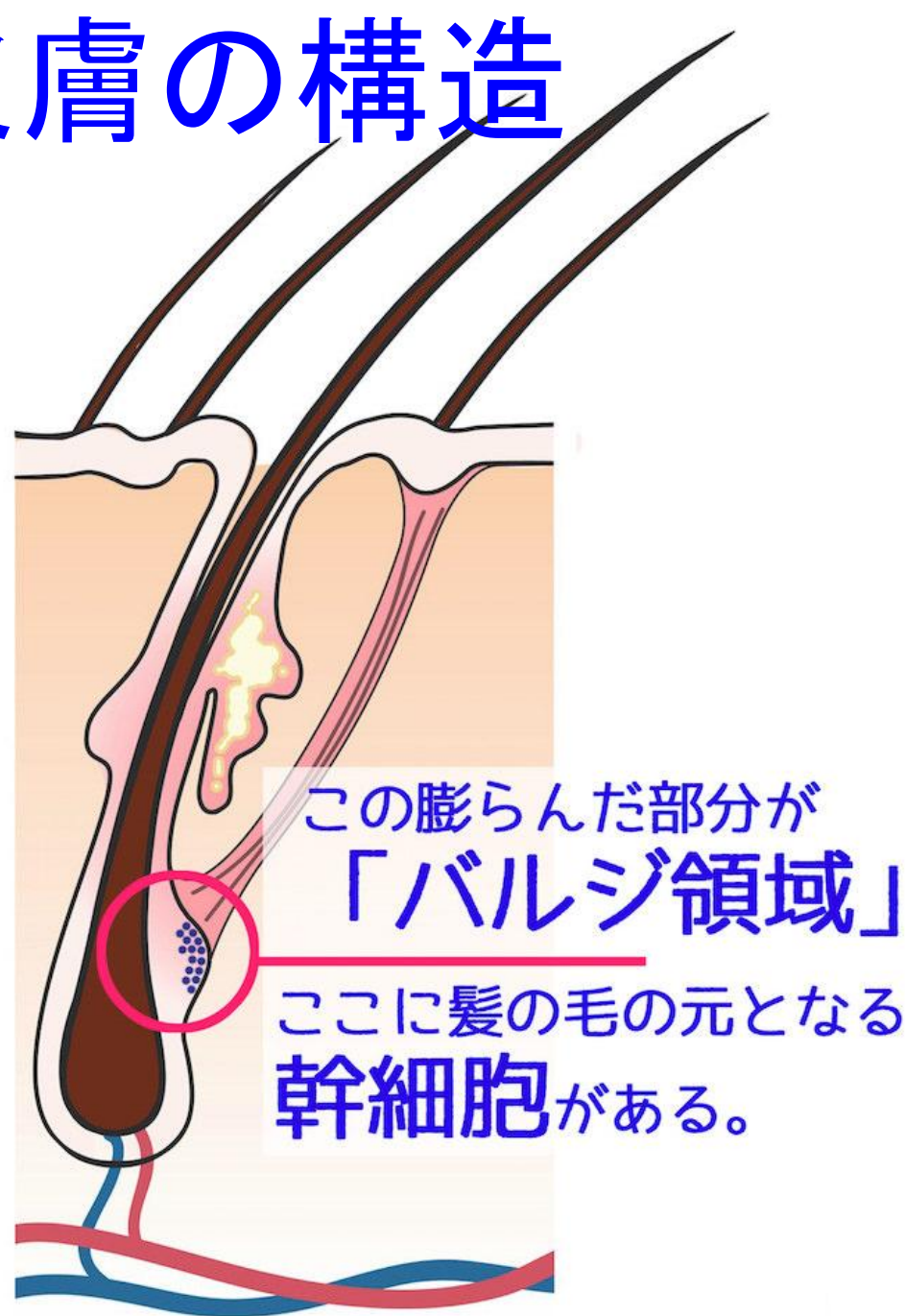
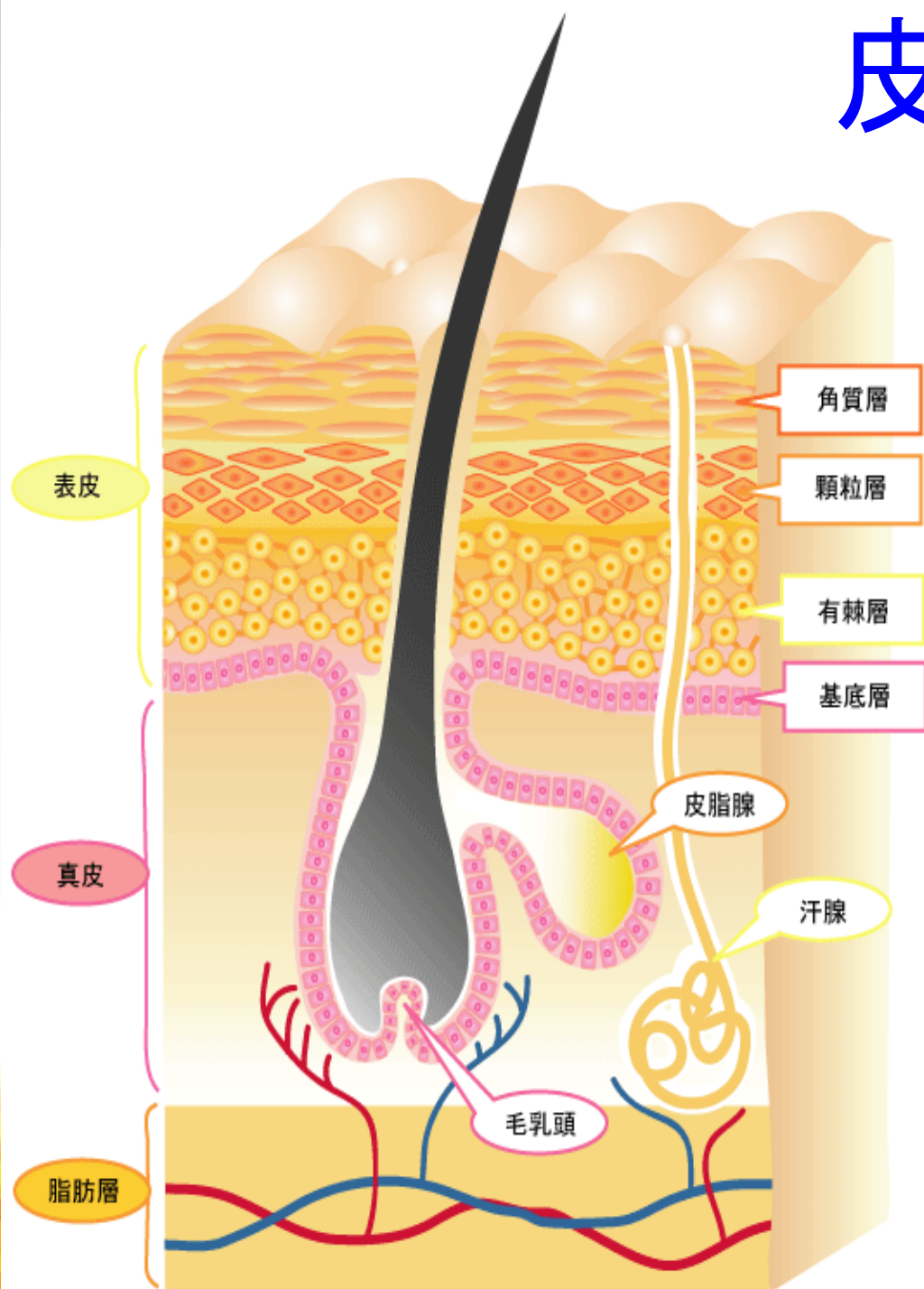
"Tupsim isttunce monice mirs.
Boid simsits and inret of
sexcu fumislipot and surctios of
copecuantog loy, suspueculs skin
bublugrams."

Subcuute tessive

muterctained of flnim a
-glimis.



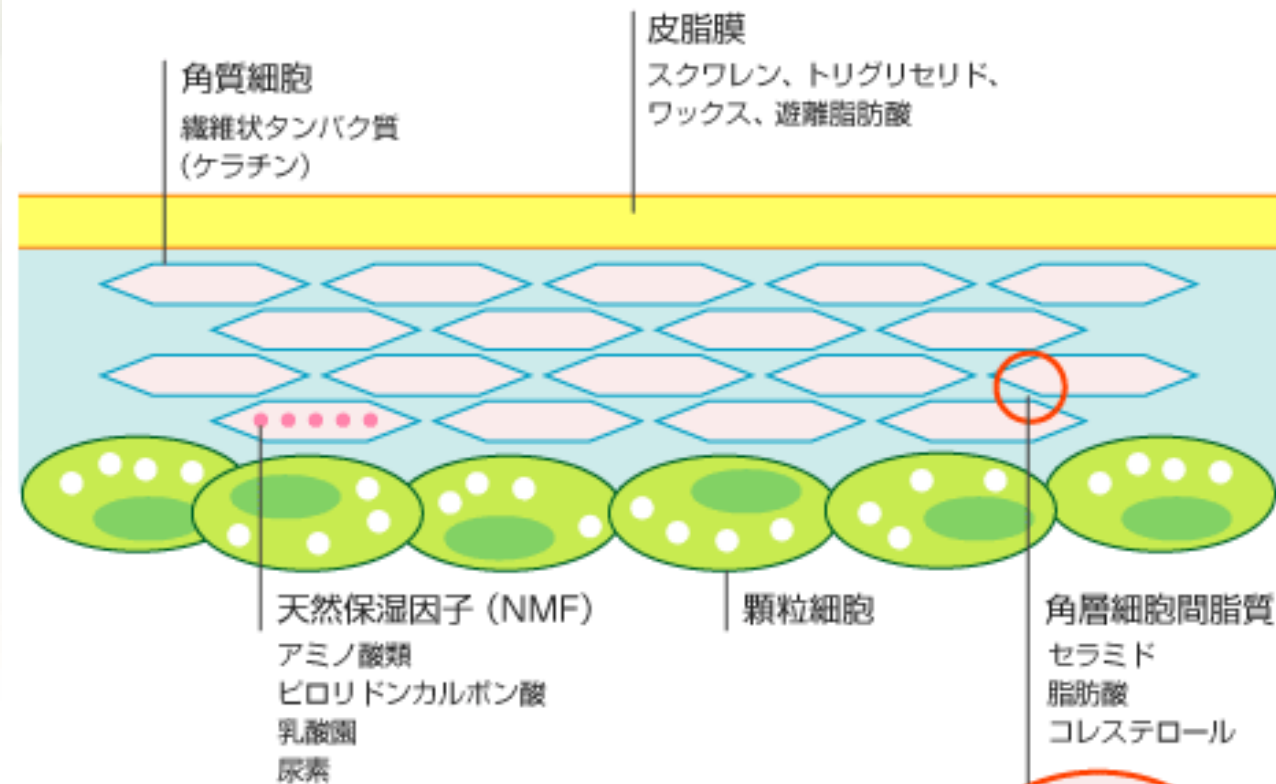
皮膚の構造



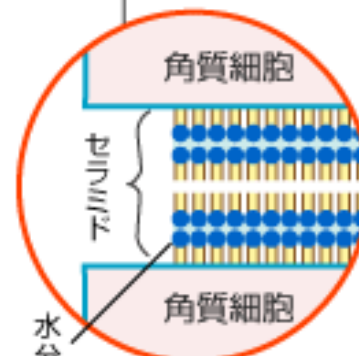
皮膚は約
1.6m²の面積、
9kg(皮下組
織含)の重量、
1.5-4.0mmの
厚さを持つ、
ヒト最大の臓
器であり、いく
つかの重要な
働きを持つ。

皮膚の構造（角層）

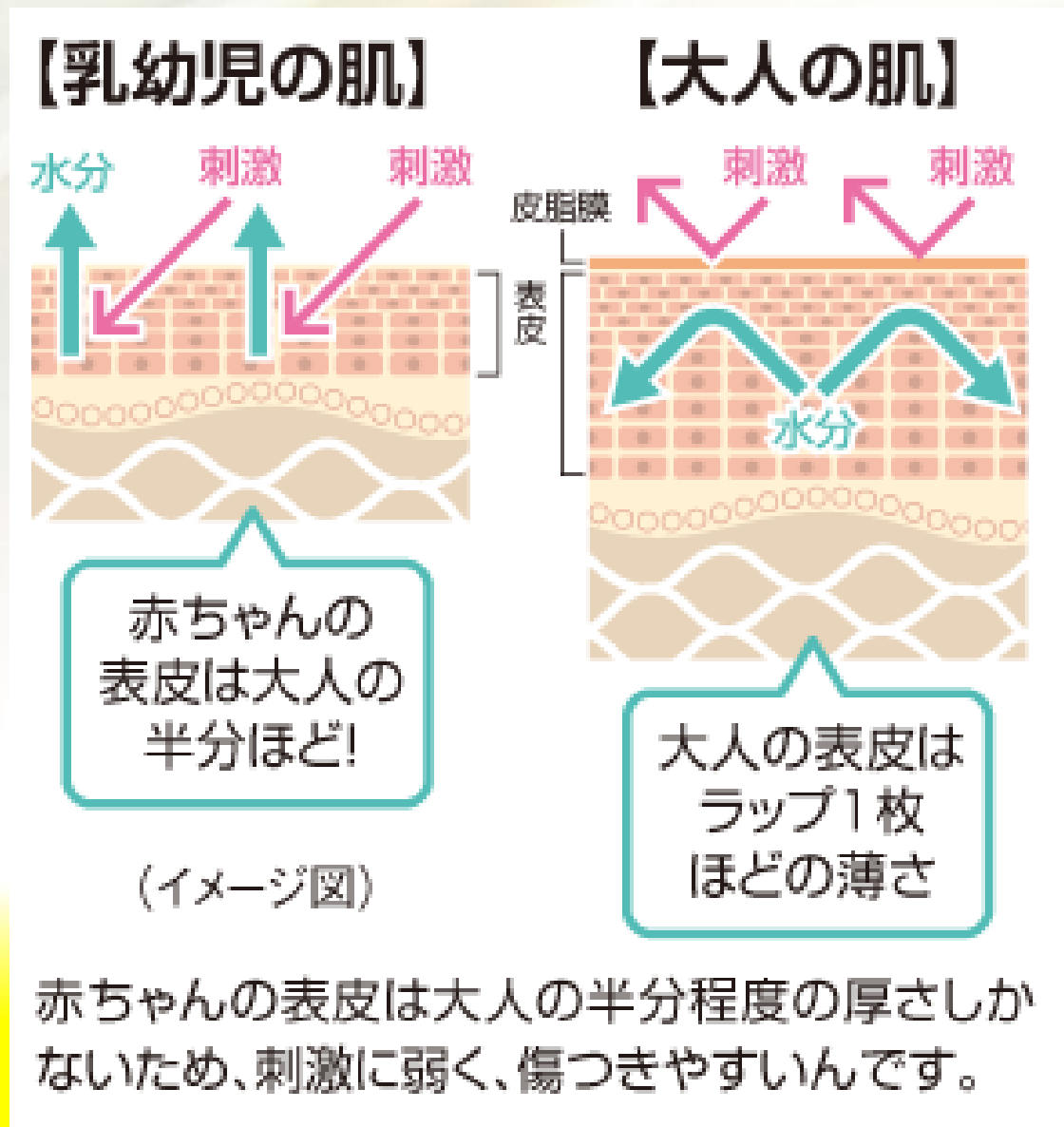
皮膚表面の保湿因子



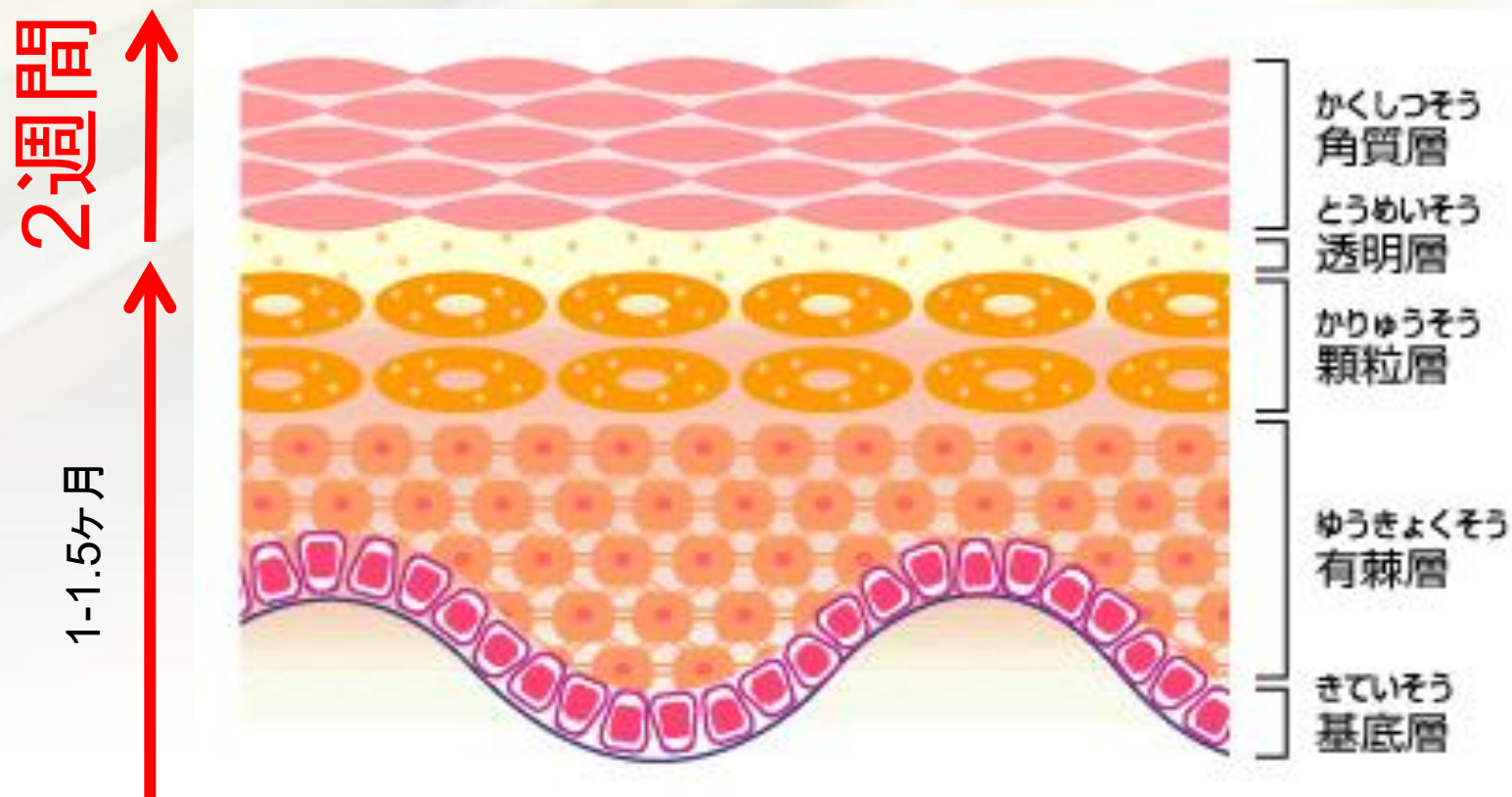
角質は最も外側に位置する皮膚のバリアであり、外側から皮脂膜、角質細胞という順で存在しています。角質細胞と角質細胞の間には**セラミド**という分子が存在し、これが水分の保持を行っています。



こどもの皮膚と大人の皮膚の違い



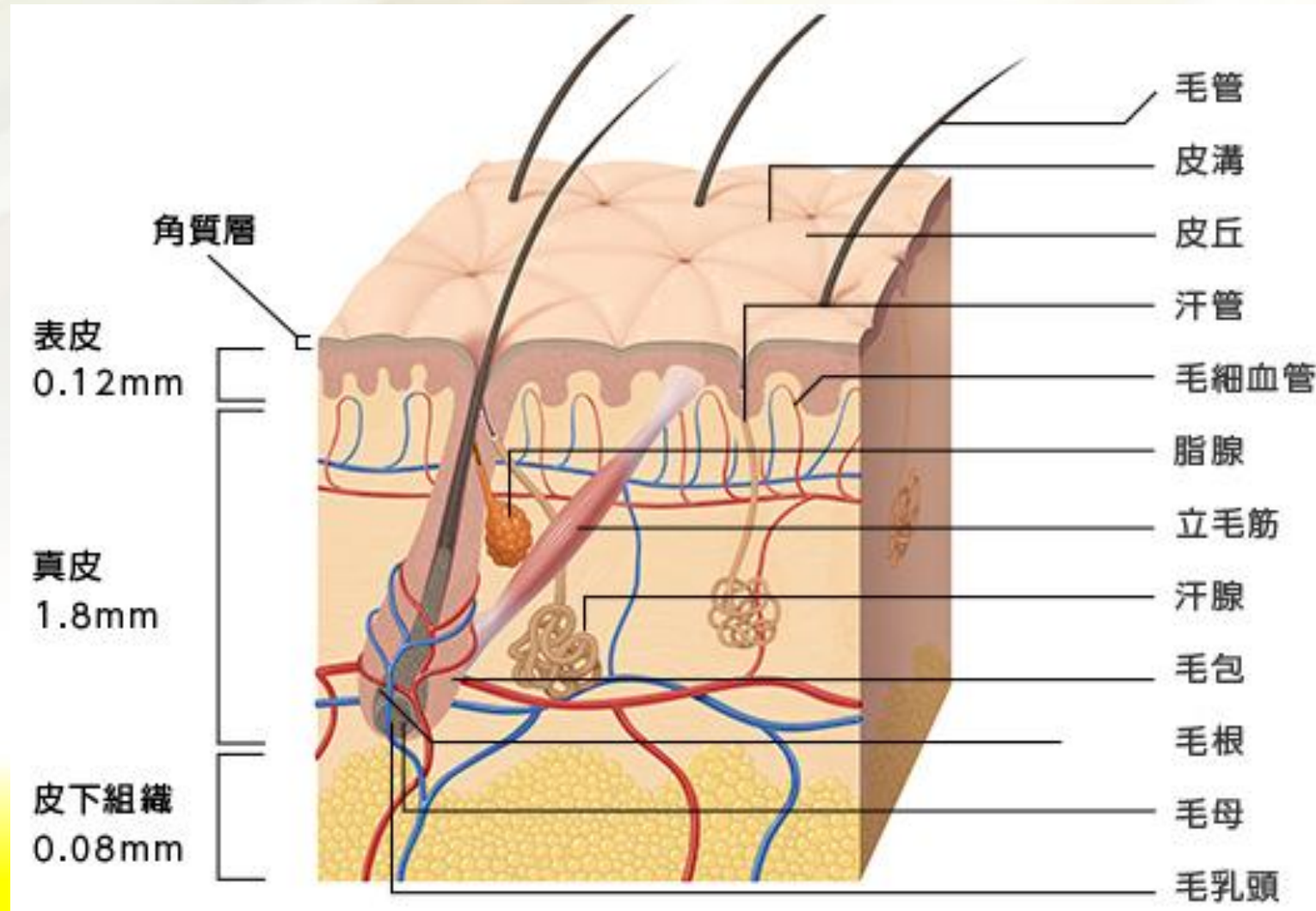
皮膚の構造（表皮）



表皮の厚さは 0.06-0.2mm （掌蹠では0.6mm）

表皮は内部から、基底層、有棘層、顆粒層、透明層、角質と分化し垢としてはがれる様になっています。

皮膚の構造(真皮)

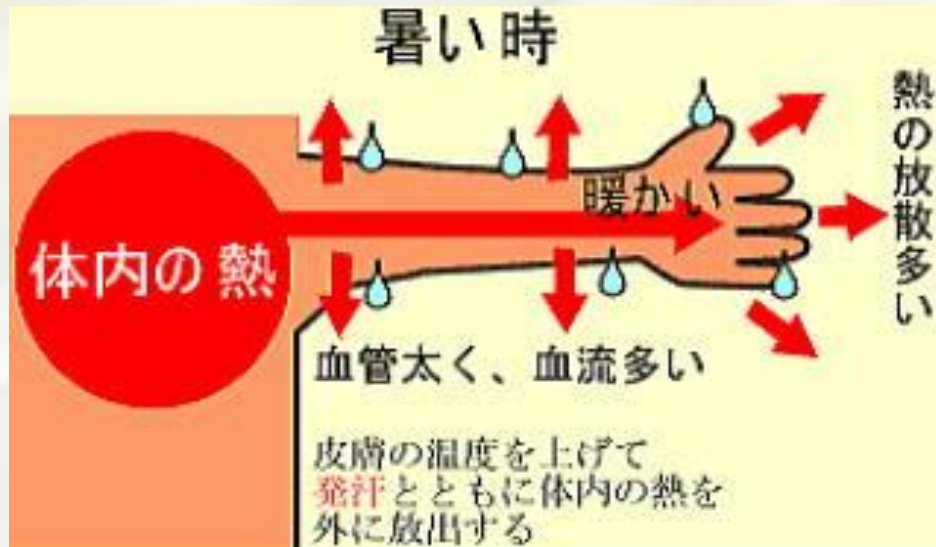


皮膚の働き(防御)

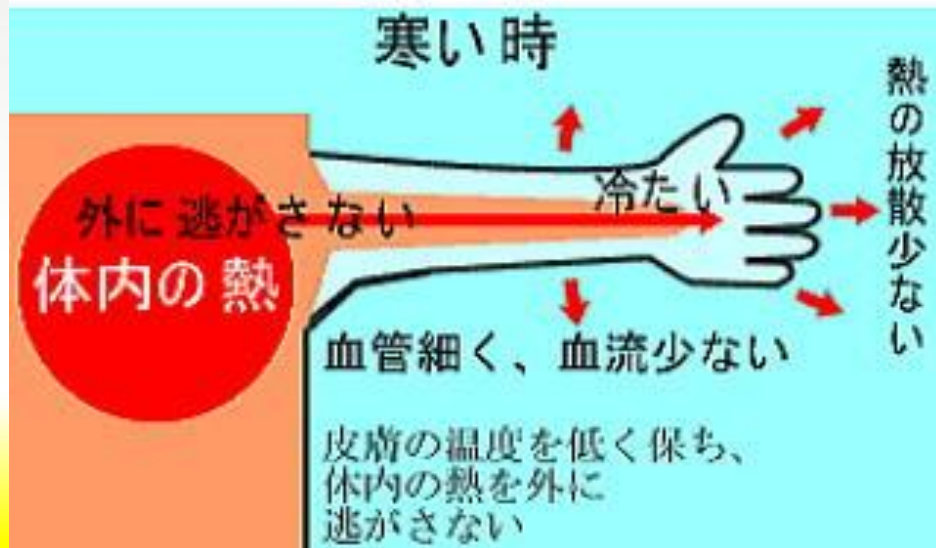


皮膚の機能として最も重要であるのが防御です。大きな動物ほど、自分の体重を支えるため皮膚は厚いと言われています。

皮膚の働き(体温調節)

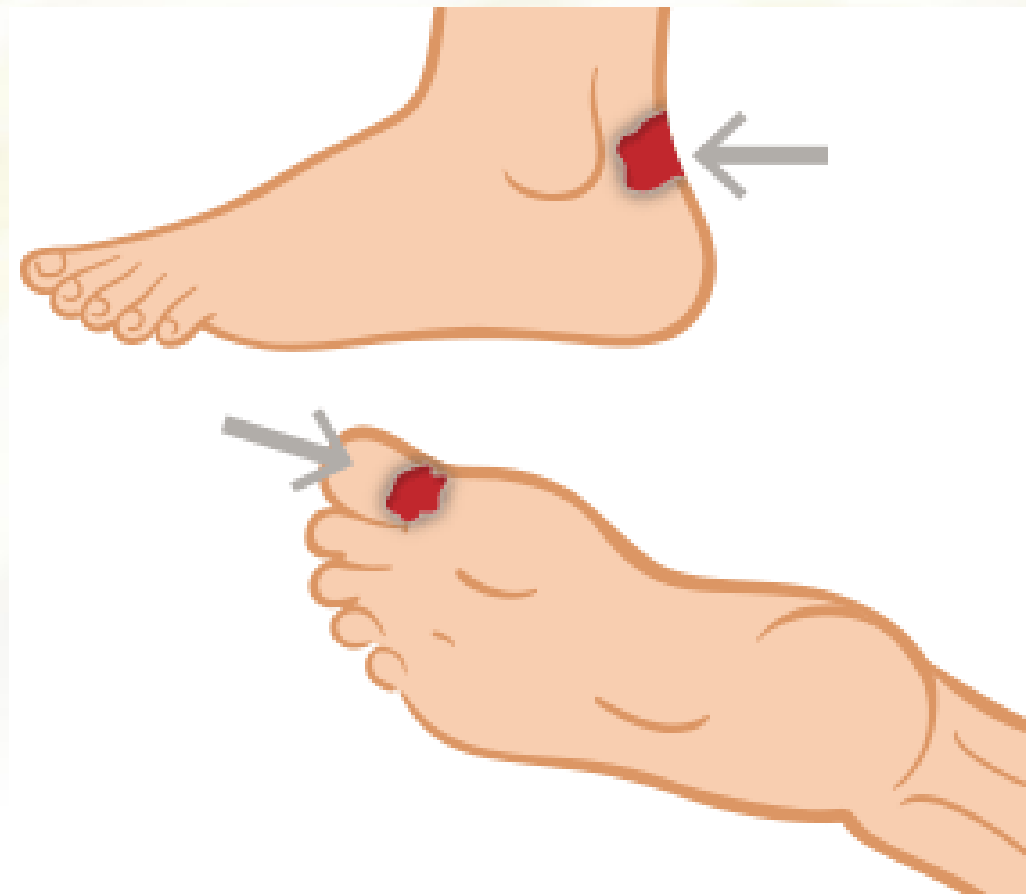


- ・汗をかく
- ・末梢(四肢)の血管が広がる



- ・末梢(四肢)の血管が縮まる
→手足が冷えやすい
- ・手足に行っていた血液が体幹に
→よく尿がでる。
- ・鳥肌が立つ
→毛穴が閉じ、体表面積が減少する。

皮膚の働き(感覚)



感覚(触覚、温痛覚)も重要な働きの一つです。親子のはぐくみもこの感覚を元に成り立つとされ、糖尿病性神経障害などでこの機能が障害されると糖尿病性皮膚潰瘍などの原因になります。

皮膚科医の診断法について



皮膚科医の診断プロセスはこのような形ですが、このうち、とっかかりとなる最も重要な点が「皮疹」です。

皮疹とは

皮膚に生じた病変を何と呼ぶかというルール
皮膚科医は皮疹のパターン、分布、時間的経過、バックグラウンドなどから診断を行っている。

→これを知らずに皮膚を見るのは、ルールを知らずにサッカーを見るようなもの。



斑

盛り上がりのない皮膚の変化（皮膚自体は正常）

- 1)紅斑
- 2)紫斑
- 3)色素斑
- 4)脱色素斑



紅斑



皮膚の炎症や血管拡張を
反映する。

「発赤」は皮疹名ではない

伝染性紅斑

紫斑

赤血球の血管外漏出によってみられる

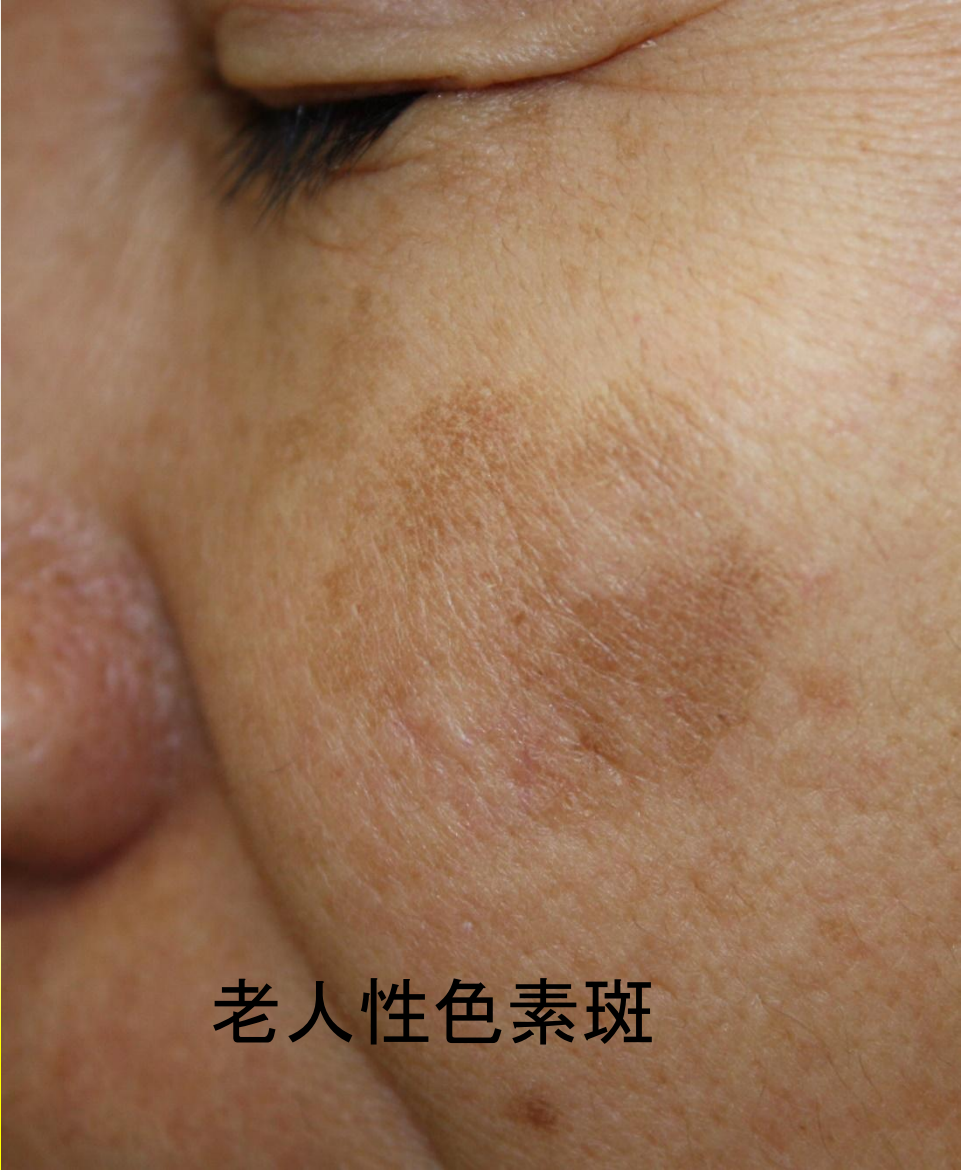
2mm以上のものを斑状出血といい、それ以下のものを点状出血という。



老人性紫斑

怒責性紫斑

色素斑(色素沈着)



物質の沈着により褐色、黄色、青色などを来す斑で盛り上がりのない(少ない)もの

老人性色素斑

白斑(色素脱失)



皮膚の色素が消失するもの

尋常性白斑

丘疹



1mm-10mmのやや
盛り上がりのあるもの
(本によっては5mm
以下との記載もあり)

顔面播種状粟粒性狼瘡

腫瘤、結節



悪性黒色腫

10-20mm程度の皮膚
の盛り上がりを経節と
いい、30mm以上もの
を腫瘤という



母斑細胞母斑

局面



皮膚面から隆起したある程度以上の大きさ(2cm以上とされる)を持った皮疹、2cm未満のものを小局面という。

水疱



いわゆるみずぶくれ
中には透明な液体が
貯留する

水疱性類天疱瘡

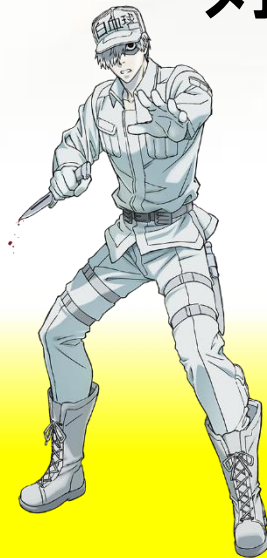
膿疱



掌蹠膿疱症

いわゆる「膿」
白濁した液体が内部に貯留
する。

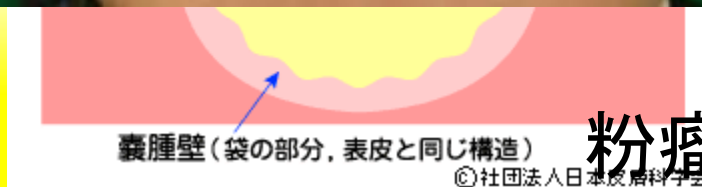
好中球の浸潤が起こるため
に引き起こされる



囊胞(囊腫)



閉鎖した空間に液体ないし半
固形の物質が含有される



囊腫壁(袋の部分, 表皮と同じ構造)

© 社団法人日本皮膚科学会

粉瘤(表皮囊腫)

膨疹



皮膚の浮腫による白色（赤みを伴う事も多い）の一過性皮疹

じんましん

びらん



表皮までの欠損のこと。
見た目は薄皮がむけている。

潰瘍



真皮より深部の皮膚欠損
のこと。深い傷に見える。
治る際に瘢痕を残す。

褥瘡

瘢痕



障害や病気によって破壊され
た正常組織が線維性成分で置
換されたもの

亀裂



皮膚表面にみられる線状
の段差、溝
いわゆる「ひびわれ」

萎縮



組織の陥凹のこと、真皮萎縮、皮下組織の萎縮などのバリエーションがある

進行性顔面片側萎縮症(ロンバーグ病)

鱗屑（りんせつ）



剥がれた角層が皮膚の
上に残っている状態

尋常性乾癬

痂皮



いわゆる「かさぶた」
分泌物や出血などが乾
いて皮膚の表面にみら
れるもの

伝染性膿痂疹

苔癬化



搔爬や摩擦などによって皮野、皮溝（皮膚紋理）が荒くなった状態

ヴィダール苔癬

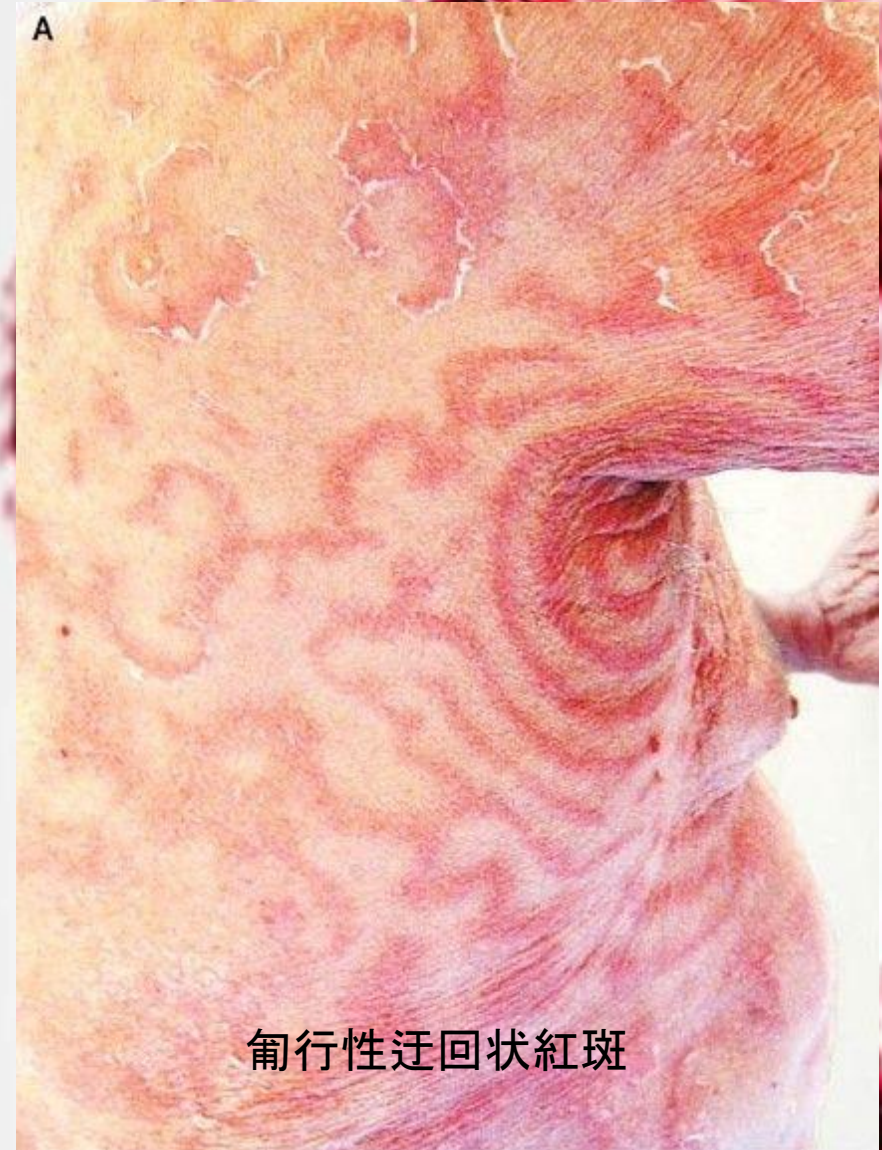
浸軟



皮膚の水分含有量が著しく上昇し、ふやけて見えること。

皮疹の形

環状
弧状
線状
円形
橢円形



匍行性迂回状紅斑

環狀

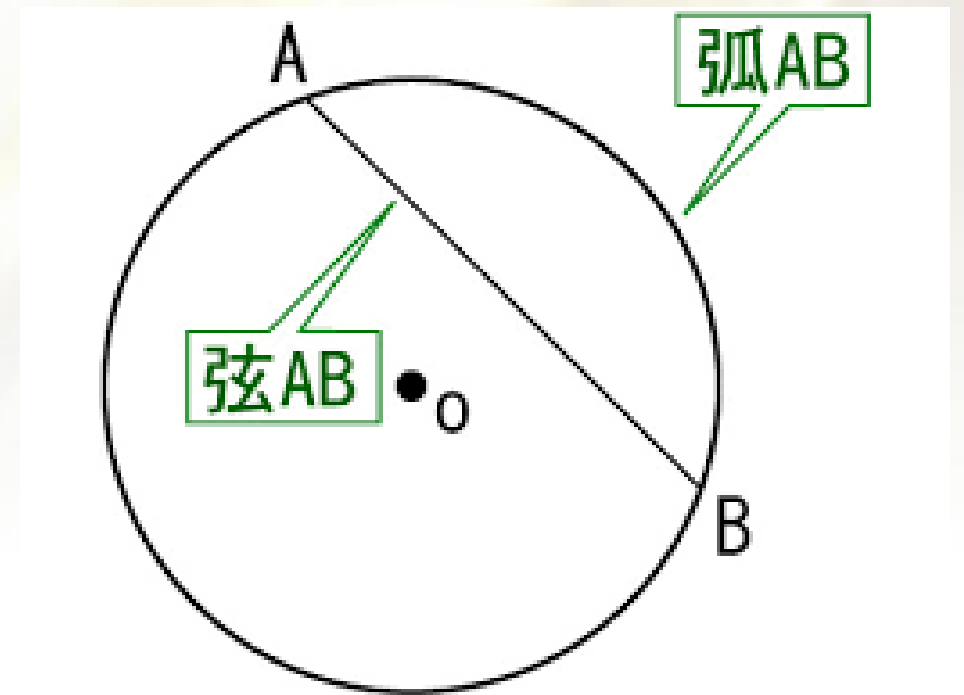


遠心性環狀紅斑

弧状



じんましん



線状



リンパ管炎

円形



尋常性乾癬

橢圓形



貨幣狀濕疹

皮疹の配列

孤立性
散在性
集簇性
環状
弧状
線状
蛇行状

散在性



ステロイドざ瘡

集簇性



带状疱疹

環狀



体部白癬

線狀



炎症性線狀疣贅狀表皮母斑

皮疹の分布

Distribution of Rashes

露光部

口囲

肛門周囲

掌蹠

露光部



光線過敏症

口 疳



Lick Dermatitis

肛門周圍



乳房外Paget病

slido

Please download and install the
Slido app on all computers you use



Audience Q&A



① Start presenting to display the audience questions on this slide.

左下腿内側(内果)にある周囲に
〇〇を伴った皮膚潰瘍

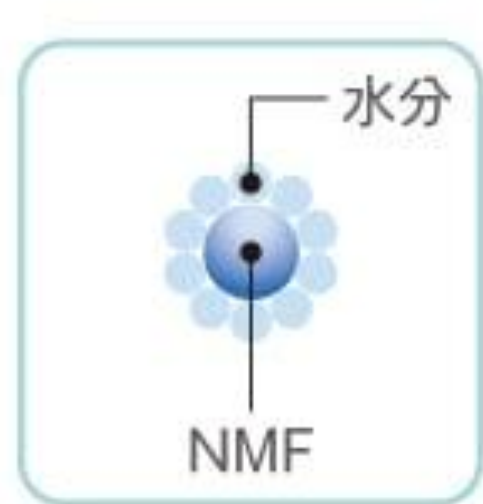


両下腿に散在性に存在する
浸潤を触れる○○

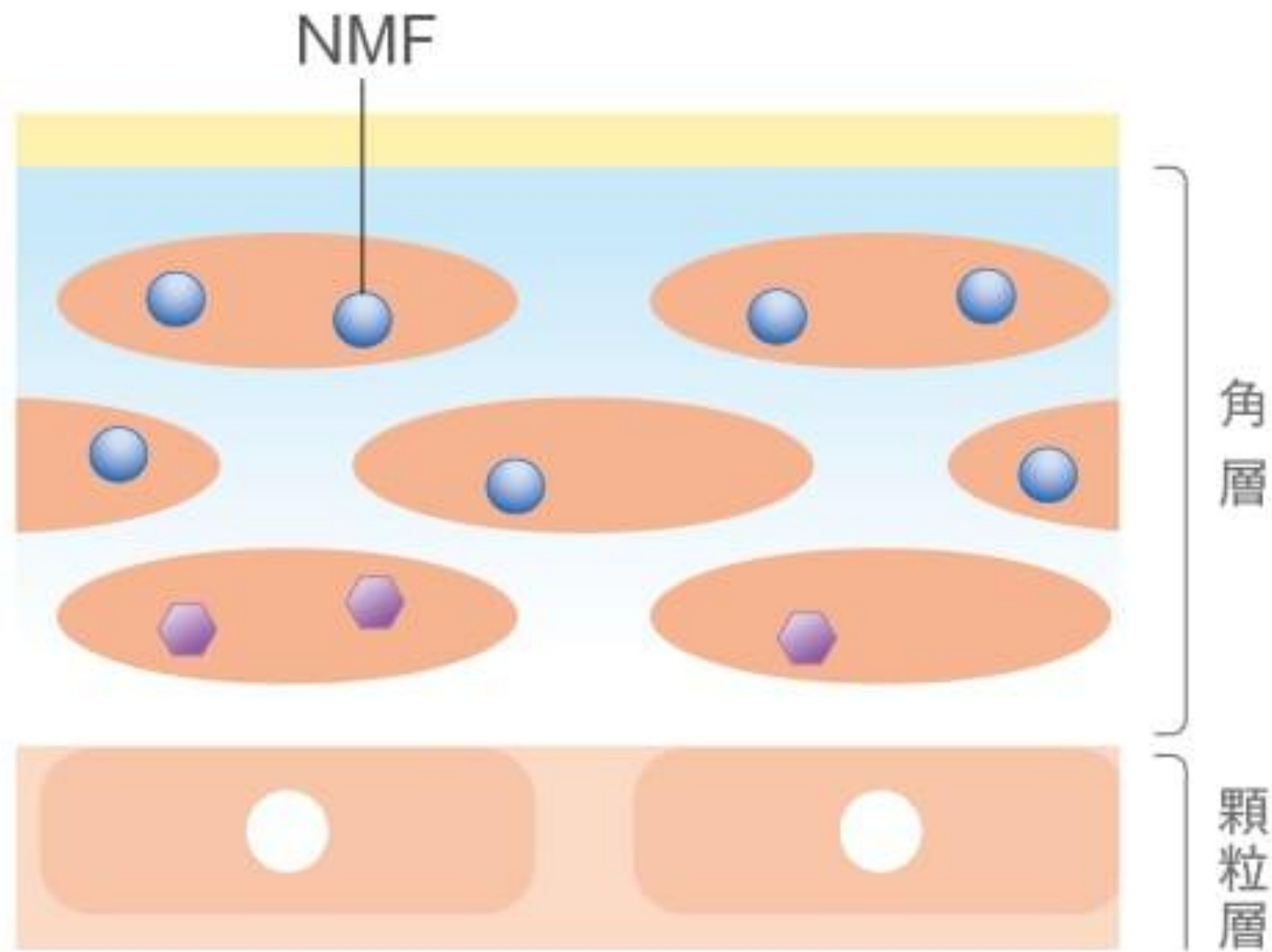


全身に散在性に存在する〇〇

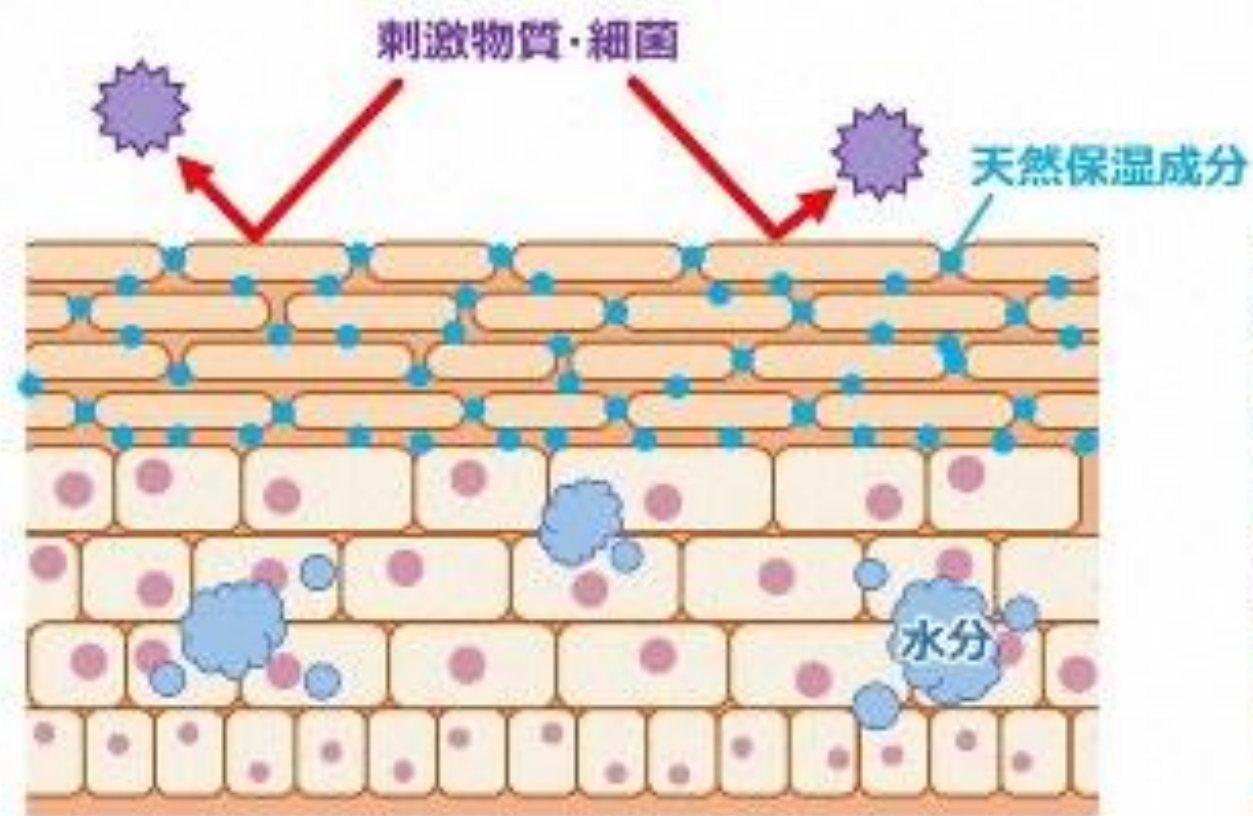
両下腿の〇〇



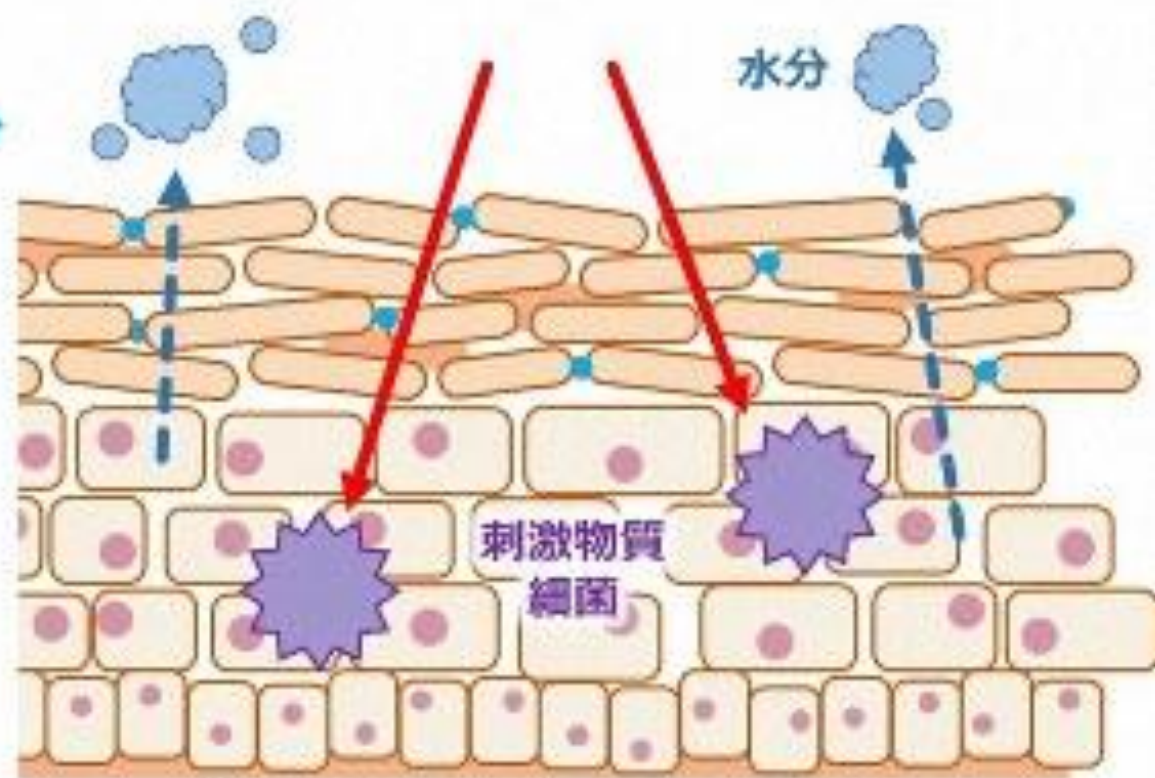
分解



天然の保湿成分（NMF※）として、お肌にうるおいを保持。



「フィラグリン」の産生が十分な肌



「フィラグリン」が不足している肌

見逃したら ヤバイ皮疹



下肢に生じた紫斑、血疱

20歳の男性。発熱と右下肢の発赤、疼痛および腫脹とを主訴に来院した。

現病歴：4日前、屋外でバスケットボールの練習中に転倒し右下腿を打撲した。次第に打撲した部位の発赤、疼痛および腫脹が出現して急速に拡がり、発熱も出現したため救急外来を受診した。

既往歴：3歳時に肺炎で入院。薬物アレルギーはない。

生活歴：大学生。バスケットボールのサークルに所属している。喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。

家族歴：父親が高血圧症で内服治療中。母親は健康。

現 症：意識レベルはJCS I-2-R。身長175cm、体重63kg。体温40.6℃。脈拍120/分、整。血圧82/40mmHg。呼吸数22/分。SpO₂ 96% (room air)。全身に発汗を認める。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。右鼠径部に径2cmで可動性良好なリンパ節を3個触知し、圧痛を認める。右下腿は打撲部位を中心に膝から足首に及ぶ著明な発赤、腫脹および圧痛を認め、皮膚表面には大小の血性水疱を認める。右膝関節および足関節は腫脹と疼痛のため十分な診察ができない。足背動脈は両側とも触知可能である。

検査所見：血液所見：赤血球468万、Hb 13.9g/dL、Ht 42%、白血球15,300（桿状核好中球30%、分葉核好中球55%、好酸球1%、好塩基球0%、単球7%、リンパ球7%）、血小板9万、PT-INR 1.6（基準0.9～1.1）、Dダイマー3.4 μg/mL（基準1.0以下）。血液生化学所見：総蛋白6.0g/dL、総ビリルビン0.9mg/dL、AST 114U/L、ALT 30U/L、LD 602U/L（基準176～353）、CK 12,200U/L（基準30～140）、尿素窒素30mg/dL、クレアチニン1.9mg/dL、血糖98mg/dL、Na 134mEq/L、K 5.0mEq/L、Cl 97mEq/L。CRP 22mg/dL。動脈血ガス分析（room air）：pH 7.30、PaCO₂ 32Torr、PaO₂ 70Torr、HCO₃⁻ 14mEq/L。骨盤部・下肢CTで右膝関節周囲から足部にかけての皮下組織と筋肉の強い浮腫像と、下腿の筋肉表面に沿った広範な液体成分の貯留像とを認める。

最も優先して行うべきなのはどれか。



感染症と癌は見逃しが怖い

69歳、女性。右下肢を虫に刺された。腫れて熱を持ちだして痛みが出てきたことから近医外科クリニックへ受診。38.4℃の発熱もあり、「下肢虫刺症」の診断で、入院加療も検討が必要として総合病院へ紹介。担当医は「带状疱疹」または「刺虫」の疑いとして帰宅処置、翌日外来に再受診され、その日の夜に自宅で意識消失、救急搬送された結果、敗血症性ショックで死亡した。



感染症と癌は見逃しが怖い

遺族は総合病院医師が壊死性筋膜炎を見逃したとして提訴、裁判に至った結果、病院側の敗訴 5,161万円の損害賠償支払いを命じた。



LRINEC スコア

壊死性筋膜炎のスコア
合計6点以上だと壊死性筋膜炎の可能性がある。

項目	状態	得点
CRP (mg/dl)	< 15	0
	≥ 15	4
白血球数 (/μl)	< 15,000	0
	15,000~25,000	1
	> 25,000	2
Hb (g/dl)	> 13.5	0
	11.0~13.5	1
	< 11.0	2
Na (mEq/l)	≥ 135	0
	< 135	2
Cre (mg/dl)	≤ 1.59	0
	> 1.59	2
Glu (mg/dl)	≤ 180	0
	> 180	1

CRP: 22 mg/dl

WBC: 15,300 /μL

Hb: 13.9 g/dL

Na: 134 mEq/L

Cre: 1.9 mg/dL

Glu: 98 mg/dL

合計 9点

60 80歳の男性。左側頭部から左頬部の皮疹を主訴に来院した。3か月前に左側頭部に紫紅色斑が出現した。次第に拡大、隆起し、出血するようになった。10年前から心房細動で抗凝固薬を服用中である。皮疹の契機について思い当たることはないという。左側頭部に皮疹を認める。鱗屑は認めない。左頸部リンパ節を触知する。左側頭部の写真(別冊No. 21)を別に示す。

最も考えられるのはどれか。

- a 血管肉腫
- b 有棘細胞癌
- c 老人性紫斑
- d 血管拡張性肉芽腫
- e 抗凝固薬の内服による紫斑



広範囲の膨疹

60歳くらいの男性。山林横の道路で意識を消失し、呼吸困難の状態で見られ救急車で搬入された。呼びかけに応答しない。顔面苦悶状。上半身に蕁麻疹と後頸部に径3cmの発赤腫脹とがある。結膜は充血している。対光反射はある。呼吸数28/分、不整。脈拍128/分、整。血圧70/40mmHg。胸部全体にwheezesを聴取する。喉頭浮腫を認める。血液所見：赤血球450万、Hb 15.5g/dL、白血球9,000。血清生化学所見：総タンパク6.2g/dL、尿素窒素18mg/dL、クレアチニン1.1mg/dL、総ビリルビン0.8mg/dL、AST 38U/L、ALT 33U/L、ChE 600単位（基準400～800）、アミラーゼ100U/L（基準37～160）、CK 20U/L（基準10～40）、Na 140mEq/L、K 3.6mEq/L、Cl 100mEq/L。動脈血ガス分析（自発呼吸、酸素5L/分投与下）：pH 7.30、PaO₂ 96Torr、PaCO₂ 48Torr、HCO₃⁻ 23mEq/L。心電図には洞性頻脈の他に異常なく、胸部エックス線写真にも異常を認めない。

治療薬で適切でないのはどれか。



A



B

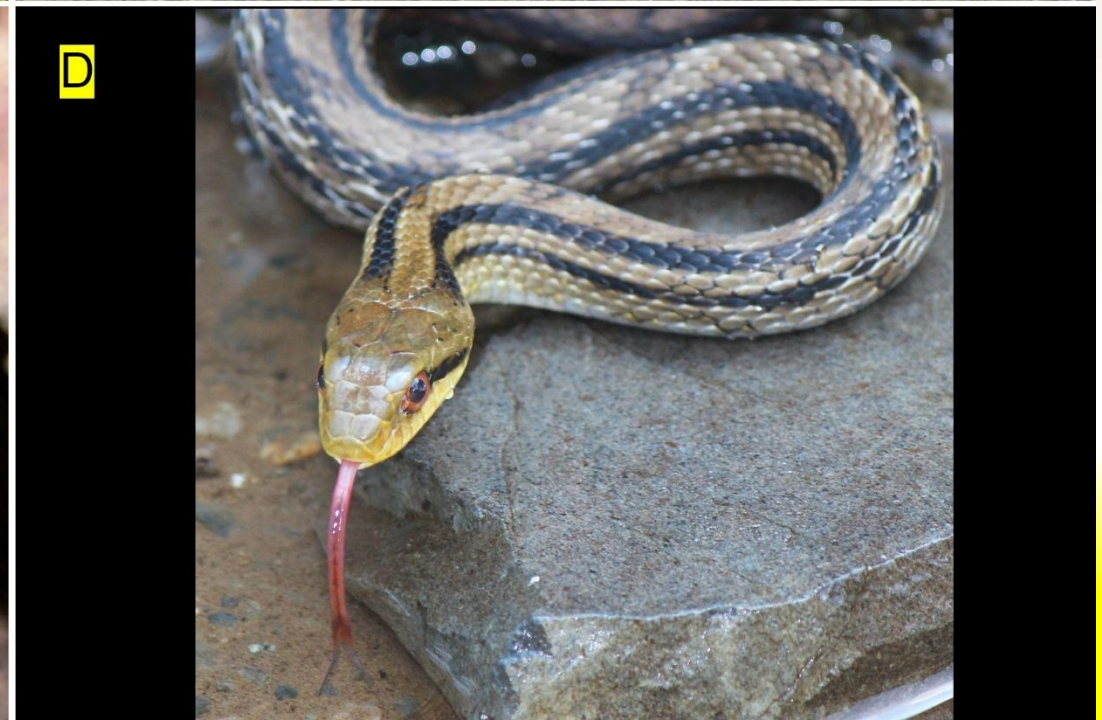


C



D





〇〇に関する皮疹

